

Организация здравоохранения и общественное здоровье

© Смирнова Л.Е., Вагнер В.Д., 2019

Смирнова Л.Е., Вагнер В.Д.

САНАЦИЯ РТА ПАЦИЕНТОВ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧАСТНОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, 119021, Москва

♦ Санация рта – комплекс мероприятий, направленных на излечение болезней органов и тканей рта, включающий лечение кариеса зубов, его осложнений, некариозных поражений и проведение профессиональной гигиены или подготовку рта к дальнейшему ортодонтическому и ортопедическому лечению. Санацию рта можно рассматривать как показатель качества медицинской помощи, так как она является запланированным результатом лечения всего организма в целом. Однако данный показатель не подлежит учету и анализу в частных медицинских организациях, в результате чего статистические данные об истинном положении стоматологической заболеваемости и эффективности лечения являются недостоверными. Нами проведено исследование по изучению деятельности четырех частных стоматологических организаций по достижению результативности лечения пациентов. Оценку объемов и стоимость выполненных работ, завершаемых санацией рта, осуществляли по Акту выполненных работ. Сбор данных по структуре стоматологической заболеваемости по обращаемости изучали по медицинским картам стоматологического больного. Причину отказа от продолжения лечения до санации рта изучали методом интервьюирования (телефонного опроса) пациентов, осуществляемого сотрудниками частных стоматологических организаций (медицинских регистраторов). Деятельность медицинских организаций, независимо от формы собственности, должна включать углубленный анализ статистической информации, являющийся частью процесса управления в здравоохранении, обеспечивающий укрепление здоровья населения и эффективность функционирования системы здравоохранения. Статистика выявляет проблемы, приоритетные направления и задачи для рационального использования кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов. В связи с этим, все стоматологические организации должны предоставлять статистические данные о своей деятельности в соответствующие органы управления здравоохранением и проводить комплекс социально-экономических мер, направленных на конечный результат стоматологического оздоровления населения, способствовать укреплению здоровья и благополучию человека через санацию рта.

Ключевые слова: санация рта, частные стоматологические организации.

Для цитирования: Смирнова Л.Е., Вагнер В.Д. Санация рта пациентов в стоматологических организациях частной системы здравоохранения. *Российский медицинский журнал*. 2019; 25(4): 194-198.
DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-4-194-198>

Для корреспонденции: Смирнова Людмила Евгеньевна, канд. мед. наук, старший научный сотрудник отдела организации стоматологической службы, лицензирования и аккредитации ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, Lesmit-7@yandex.ru

Smirnova L.E., Vagner V.D.

SANATION OF PATIENTS' MOUTH IN DENTAL ORGANIZATIONS OF PRIVATE HEALTH CARE SYSTEM

Central Research Institute of Dental and Maxillofacial Surgery, 119021, Moscow, Russian Federation

♦ Oral sanitation – a set of measures aimed at curing diseases of the organs and tissues of the mouth, including the treatment of dental caries, its complications, non-carious lesions and professional hygiene or preparation of the mouth for further orthodontic and orthopedic treatment. Sanation of the mouth can be considered as an indicator of the quality of medical care, as it is a planned result of the treatment of the whole body. However, this indicator is not subject to accounting and analysis in private medical organizations, as a result of which statistical data on the true situation of dental disease and the effectiveness of treatment are unreliable. We conducted a study on the activities of four private dental organizations to achieve the effectiveness of treatment of patients. Evaluation of the scope and cost of work performed, complete rehabilitation of the mouth, carried out the certificate of completion. The collection of data on the structure of dental morbidity by turnover was studied by the medical records of the dental patient. The reason for the refusal to continue treatment before the rehabilitation of the mouth was studied by interviewing (telephone survey) of patients carried out by employees of private dental organizations (medical registrars). The activities of medical organizations, regardless of ownership, should include an in-depth analysis of statistical information, which is part of the management process in health care, ensuring the strengthening of public health and the effectiveness of the health system. Statistics reveal problems, priorities and challenges for the rational use of human, financial and logistical resources. In this regard, all offices of the organization must provide statistical data on their activities to the appropriate authorities and a range of socio-economic measures aimed at the final result of the dental Wellness of the population, strengthen the health and well-being of the person through the reorganization of the mouth.

Keywords: sanation of the mouth; private dental institutions.

For citation: Smirnova L.E., Vagner V.D. Sanation of patients' mouth in dental organizations of private health care system. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2019; 25(4): 194-198. (in Russ)
DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2019-25-4-194-198>

For correspondence: Lyudmila E. Smirnova, candidate of medical sciences, senior researcher of the Department of organization of dental service, licensing and accreditation Central Research Institute of Dental and Maxillofacial Surgery, 119021, Moscow, Russian Federation, E-mail: Lesmit-7@yandex.ru

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

Received 28.08.19

Accepted 26.09.19

Актуальность

Санация рта – комплекс мероприятий, направленных на излечение болезней органов и тканей рта, включающий лечение кариеса зубов, его осложнений, некариозных поражений и проведение профессиональной гигиены или подготовку рта к дальнейшему ортодонтическому и ортопедическому лечению [1,2]. Санацию рта можно рассматривать как показатель качества медицинской помощи, так как она является запланированным результатом лечения всего организма в целом.

Для отчетной оценки деятельности стоматологической организации государственного сектора рассчитываются такие показатели, как доля санированных из общего числа первичных больных, доля лиц, нуждающихся в санации рта от числа планово-осмотренных (в порядке плановой санации), доля санированных лиц из числа нуждающихся, выявленных при плановом осмотре, число выявленных лиц, нуждающихся в санации рта, среднее число санаций (санированных больных) в день на одного врача, но они не подлежат учету и анализу в частных медицинских организациях, в результате чего статистические данные об истинном положении стоматологической заболеваемости и эффективности лечения являются недостоверными.

Цель. Обеспечение качества медицинской помощи за счет достижения высокой степени результативности стоматологического лечения.

Материал и методы

Базой исследования послужили четыре стоматологические организации (СО) в Москве и Московской области, предоставляющие платные услуги за счет средств граждан. Оценка объемов и стоимость выполненных работ, завершенных санацией рта, осуществляли по Акту выполненных работ. Сбор данных по структуре стоматологической заболеваемости по обращаемости изучали по медицинским картам стоматологического больного. Причину отказа от продолжения лечения до санации рта изучали методом интервьюирования (телефонного опроса) пациентов, осуществляемого сотрудниками частных стоматологических организаций (медицинских регистраторов).

Результаты

Проведена экспертиза 1437 медицинских карт пациентов, которые впервые обратились за стоматологической терапевтической и хирургической помощью в течение 2018 г. в четыре СО, находящиеся на рынке стоматологических услуг $12,25 \pm 1,32$ года, относящиеся к сегменту эконом-класса, по типу частных клиник – одиночные. Все обратившиеся (осмотренные) в данные СО нуждались в стоматологическом лечении, среди них санированными оказались 418 человек (в среднем $105,0 \pm 38,0$) на конец года, что составило 29,1%. Возраст

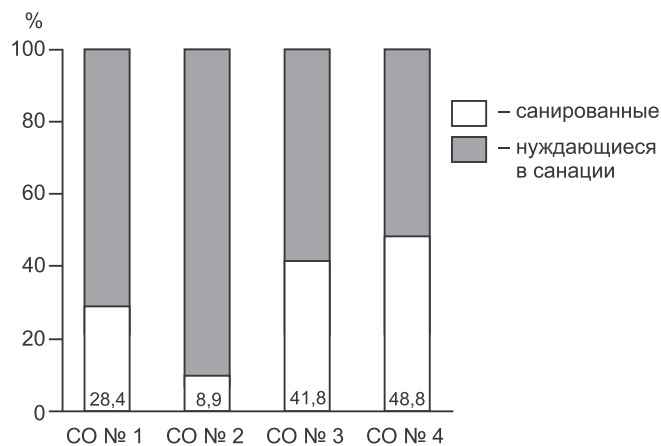


Рис. 1. Показатели профилактической работы врачей-стоматологов.

санированных – $43,8 \pm 2,75$ года, количество посещений для санации равно $2,8 \pm 0,56$, средняя стоимость санации измеряется в размере $22940,25 \pm 6998,86$ рублей.

В СО № 1 число первично обратившихся в 2018 г. пациентов составило 197 человек, санированных – 28,4% от осмотренных, санация осуществлялась за $2,07 \pm 0,18$ посещений, стоимость стоматологического здоровья составила $12670,2 \pm 1023,4$ рублей.

В СО № 2 число первичных пациентов – 520, из них санированных – 8,9%, число посещений, необходимых для санации пациентов составило $4,5 \pm 0,32$, стоимость санации – $43627 \pm 4856,8$ рублей.

В СО № 3 число первично обратившихся – 507, санированных – 41,8% за $2,5 \pm 0,15$ посещения со средней стоимостью лечения $17471,48 \pm 1323,5$ рублей.

В СО № 4 из 213 первичных пациентов, санированными оказались 48,8% за $2,3 \pm 0,15$ посещения, стоимость лечения составила $17993,06 \pm 1434,9$ рублей (табл. 1).

В СО № 2 зафиксирован наименьший процент санированных, наибольшее количество посещений и стоимость стоматологических услуг, необходимых для санации.

В СО № 2, где зафиксирован наибольший приток первичных пациентов (средний возраст $36,37 \pm 1,55$), санация рта, как степень результативности лечения, находится на самом низком уровне (8,9%) (рис. 1).

Средний показатель индекса КПУ у пациентов частных стоматологических организаций находится в пределах от $12,6 \pm 0,95$ (СО №2) до $14,63 \pm 0,96$ (СО №4). По шкале относительной оценки интенсивности кариеса эти данные соответствуют высокой интенсивности (12,8-16,2) (табл. 2). В 1990 году разработан метод определения индекса, позволяющий определить индивидуальный и групповой уровни интенсивности кариеса (УИК) зубов по значению КПУ зубов в любом возрасте человека [3]. Для определения УИК постоянных зубов

Таблица 1

Показатели деятельности стоматологической организации

Параметры	Медицинская организация № 1	Медицинская организация № 2	Медицинская организация № 3	Медицинская организация № 4
Число первичных пациентов за 2018 год	197	520	507	213
Число санированных от первичных	56 (28,4%)	46 (8,9%)	212 (41,8%)	104 (48,8%)
Количество посещений на санацию	$2,07 \pm 0,18$	$4,5 \pm 0,32$	$2,5 \pm 0,15$	$2,3 \pm 0,15$
Стоимость санации	$12670,2 \pm 1023,4$	$43627 \pm 4856,8$	$17471,48 \pm 1323,5$	$17993,06 \pm 1434,9$

Таблица 2

Интенсивность кариеса у пациентов частных стоматологических организаций

Параметры		Медицинская организация № 1	Медицинская организация № 2	Медицинская организация № 3	Медицинская организация № 4
Составляющие индекса КПУ	К	2,0±1,79	4,2±0,43	2,6±0,19	1,9±0,16
	П	7,07±0,32	6,6±0,29	7,78±0,16	9,03±0,43
	У	3,69±0,31	1,8±0,23	3,1±0,21	3,7±0,39
КПУ		12,76±0,81	12,6±0,95	13,48±0,56	14,63±0,96
Возраст пациентов		45,01±2,21	36,37±1,55	45,4±0,97	49,5±1,69

у взрослого населения применяется формула УИК. В нашем исследовании $УИК = 13,3675/4,8 = 0,31$, что также выявляет высокий уровень интенсивности кариеса.

В медицинских картах стоматологического больного (МКСБ) во всех СО были установлены следующие диагнозы с последующим осуществлением плана терапевтического и хирургического лечения: К02.1 – кариес дентина, К04.00 – начальный (гиперемия) пульпит, К04.01 – острый пульпит, К04.03 – хронический пульпит, К04.4 – острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения, К04.5 – хронический апикальный периодонтит (апикальная гранулема), К05.1 – хронический гингивит, К05.30 – хронический локализованный пародонтит, К05.31 – хронический генерализованный пародонтит, К03.80 – чувствительный дентин, К04.80 – апикальная и боковая кисты (табл. 3).

Для санации рта пациентов частных стоматологических организаций наиболее распространенной услугой явилось лечение кариеса дентина, встречаемость которого в среднем составила $64,2\% \pm 9,2$. На втором месте – лечение пульпита $22,7\% \pm 3,8$, по поводу начального пульпита услуги оказывались в $16,6\% \pm 4,1$ случаев, далее следует лечение периодонтита и удаление зубов – по $12,1\%$ случаев (см. табл. 3, рис. 2). В медицинских картах стоматологического больного в записях врача отметка об обучении пациентов гигиене рта имела только в трех СО, в СО № 2 в 28,3%, в СО № 3 в 32,1%, в СО № 3 в 40,1% случаев. Снятие зубных отложений при лечении гингивита отмечено во всех СО, в № 1 – 28,6%, в № 2 – 43,5%, в № 3 – 32,1%, в № 4 – 39,4% случаев; при лечении пародонтита оказывались те же стоматологические услуги в СО № 2 в 6,5%, № 3 в 3,3%, № 4 в 7,7% случаев.

По данным агентства BusinessStat объем рынка стоматологических услуг в России в 2018 году составил 271 млн приемов, из них 69% приходилось на сектор ОМС. К сожалению, увеличению объема стоматологических услуг будет способствовать сохранение высокого уровня заболеваемости кариесом в стране, как среди взрослых, так и среди детей [4].

В результате нашего исследования установлено, что из нуждающихся в стоматологическом лечении и обратившихся в частные СО, санированными оказались только 29,1% пациентов. Методом интервьюирования, целью которого было выяснения причин расторжения договора на оказания медицинских услуг, были опрошены пациенты СО, которые не завершили стоматологическое лечение санацией рта, их оказалось 411 (40,3%) человек. Опрос проводили девять сотрудников СО, на базе которых проводили исследование. Большинство респондентов (38%) ответили, что планируют дальнейшее лечение, но позже (откладывают деньги на учебу детей и отпуск), только пациенты из СО № 2 (19%) назвали причину дороговизны услуг, отсутствие болевых ощущений остановили от продолжения лечения 17%, из-за сложного рабочего графика 15% пациентов, поменяли место жительства/прописки 8%, у 3% опрошенных врач-стоматолог не вызвал доверия. Отличительной положительной чертой организации деятельности СО № 3 и № 4, по мнению пациентов, явилось регулярное, раз в полгода, напоминание по телефону о необходимости дальнейшего лечения.

Заключение

Деятельность медицинских организаций, независимо от формы собственности, должна включать углублен-

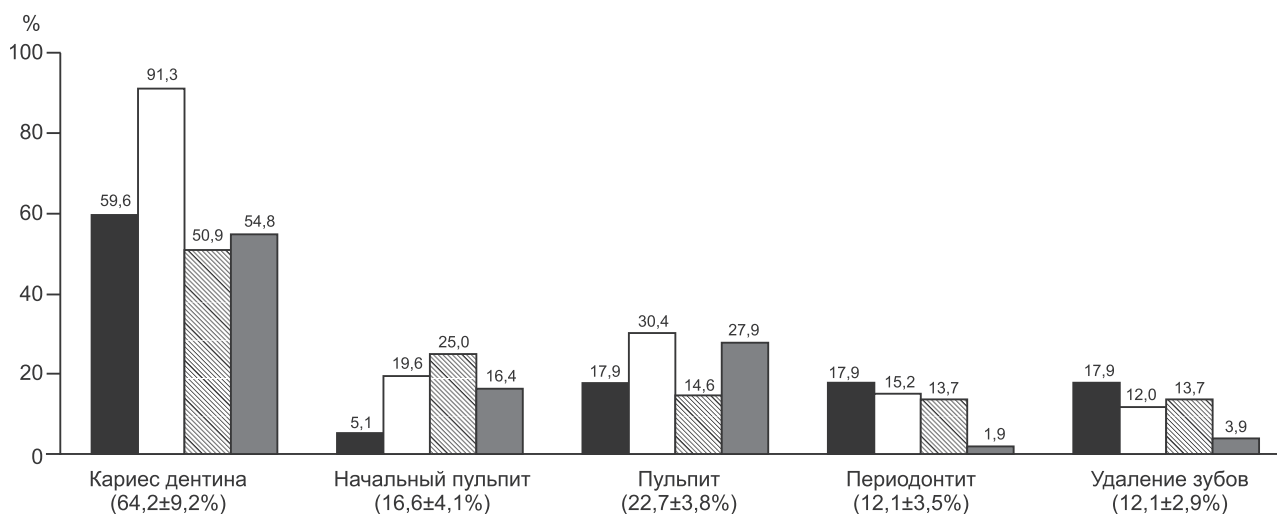


Рис. 2. Объем стоматологических услуг для санации пациентов частных стоматологических организаций.

Таблица 3

Встречаемость диагнозов и манипуляций при санации рта у пациентов частных стоматологических организаций

Параметры	Медицинская организация № 1 (n=56)	Медицинская организация № 2 (n=46)	Медицинская организация № 3 (n=212)	Медицинская организация № 4 (n=104)
Кариес зубов				
Среднее значение	1,7±0,16	3,7±0,34	2,4±0,21	1,8±0,15
Число пациентов: абс. (%)	31 (59,6)	42 (91,3)	108 (50,9)	57 (54,8)
Количество зубов с кариесом	52	157	263	104
Количество зубов: min/max	1/4	1/10	1/14	1/5
Начальный пульпит				
Среднее значение	1,0±0	1,3±0,17	1,6±0,14	1,3±0,14
Число пациентов: абс. (%)	3 (5,4)	9 (19,6)	5 (25)	17 (16,4)
Количество зубов с нач. пульпитом	3	12	85	22
Количество зубов: min/max	1/1	1/1	1/6	1/3
Пульпит				
Среднее значение	1,4±0,4	1,21±0,21	1,23±0,10	1,41±0,12
Число пациентов: абс. (%)	10 (17,9)	14 (30,4)	31 (14,6)	29 (27,9)
Количество зубов с пульпитом	14	17	38	41
Количество зубов: min/max	1/5	1/4	1/3	1/3
Периодонтит				
Среднее значение	1,8±0,51	1±0	1,2±0,08	1±0
Число пациентов: абс. (%)	10 (17,9)	7 (15,2)	29 (13,7)	2 (1,9)
Количество зубов с периодонтитом	18	7	37	2
Количество зубов: min/max	1/6	1/1	1/1	1/1
Гингивит (снятие зубных отложений)				
Среднее значение	26,3±0,65	27,1±0,21	26,8±0,36	24,1±0,97
Число пациентов: абс. (%)	16 (28,6)	20 (43,5)	68 (32,1)	41 (39,4)
Количество зубов	420	542	1823	989
Количество зубов: min/max	20/28	26/28	6/28	2/31
Пародонтит (снятие зубных отложений и медикаментозное лечение)				
Среднее значение	0	5±0	25,29±0,99	14,5±2,35
Число пациентов: абс. (%)	0	3 (6,5)	7 (3,3)	8 (7,7)
Количество зубов	0	15	177	116
Количество зубов: min/max	0	5/5	20/28	5/21
Чувствительный дентин				
Среднее значение	0	0	0	6,25±2,36
Число пациентов: абс. (%)	0	0	0	8 (7,7)
Количество зубов	0	0	0	20
Количество зубов: min/max	0	0	0	6/8
Удаление зубов				
Среднее значение	1,4±0,27	1,3±0,21	1,1±0,07	1,25±0,25
Число пациентов: абс. (%)	10 (17,9)	6 (13,04)	29 (13,7)	4 (3,9)
Количество зубов	14	8	33	5
Количество зубов: min/max	1/3	1/2	1/2	1/2
Шинирование	0	0	0	3 чел. (2,9)
Обучение гигиене: абс. (%)	0	13 (28,3)	68 (32,1)	42 (40,1)

ный анализ статистической информации, являющийся частью процесса управления в здравоохранении, обеспечивающий укрепление здоровья населения и эффективность функционирования системы здравоохранения. Статистика выявляет проблемы, приоритетные направления и задачи для рационального использования кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов. В связи с этим, все стоматологические организации должны предоставлять статистические данные о своей

деятельности в соответствующие органы управления и проводить комплекс социально-экономических мер, направленных на конечный результат стоматологического оздоровления населения, способствовать укреплению здоровья и благополучию человека через санацию рта.

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Леонтьев В.К., Пахомов Г.Н. *Профилактика стоматологических заболеваний*. М., 2006.
2. *Первичная профилактика в стоматологии*. М.: Медицина; 1982.
3. Леус П.А. Новые методы мониторинга первичной профилактики кариеса зубов. Ереванский государственный институт усовершенствования врачей. Ереван; 1990.
4. Объем рынка стоматологических услуг в России не вырос в 2018 году (Electronic resource.) Available at: <https://medvestnik.ru/content/news/Obem-rynka-stomatologicheskikh-uslug-v-Rossii-ne-vyros-v-2018-godu.html>

REFERENCES

1. Leontiev V.K., Pakhomov G.N. *Prevention of dental diseases*. Moscow: 2006. (in Russian)
2. *Primary prevention in dentistry*. Moscow: Medicine; 1982. (in Russian)
3. Leus P.A. *New methods of monitoring the primary prevention of dental caries*. Yerevan state Institute of advanced medical education. Yerevan; 1990. (in Russian)
4. The volume of the dental services market in Russia did not grow in 2018 (in Russian) (Electronic resource.) Available at: <https://medvestnik.ru/content/news/Obem-rynka-stomatologicheskikh-uslug-v-Rossii-ne-vyros-v-2018-godu.html>

Поступила 28.08.19
Принята к печати 26. 09.19